



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA KOMITE KEPERAWATAN
TRIMESTER III
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



LAPORAN KINERJA KOMITE KEPERAWATAN TRIMESTER III TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komite Keperawatan merupakan wadah nonstruktural di rumah sakit yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi. Keberadaan Komite Keperawatan sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, efektif, berorientasi pada keselamatan pasien, serta sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, Komite Keperawatan memiliki fungsi utama dalam meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui pelaksanaan kredensial, pengembangan mutu profesi, serta pembinaan etik dan disiplin profesi. Selain itu, dalam standar akreditasi rumah sakit, Komite Keperawatan berperan aktif dalam memastikan kompetensi staf keperawatan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien.

Pada Triwulan III tahun berjalan, Komite Keperawatan melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi evaluasi kewenangan klinis tenaga keperawatan, monitoring dan evaluasi kompetensi perawat, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, supervisi praktik profesional, telaah kasus keperawatan, serta pembinaan etik dan disiplin profesi. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar praktik profesional dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Selama periode Triwulan III, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja, antara lain kepatuhan dokumentasi asuhan keperawatan yang belum optimal di beberapa unit pelayanan, keterlambatan pemenuhan bukti kompetensi untuk proses rekredensial, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan profesi akibat tingginya beban kerja pelayanan, serta masih ditemukannya variasi penerapan standar praktik keperawatan antar unit. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan melalui kegiatan monitoring, edukasi, supervisi, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala.

Laporan Kinerja Komite Keperawatan Triwulan III ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Komite Keperawatan, sarana evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta dasar penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.



4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
6. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.
7. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Komite Keperawatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Keperawatan dalam menjaga profesionalisme, kompetensi, mutu praktik klinis, serta penegakan etik dan disiplin tenaga keperawatan di rumah sakit.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kredensial, rekredensial, penetapan kewenangan klinis, pembinaan mutu profesi, serta penanganan pelanggaran etik dan disiplin sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan tata kelola keperawatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui penguatan kompetensi staf, peningkatan mutu asuhan keperawatan, serta penegakan etik dan disiplin profesi secara berkelanjutan.

3. Tujuan Khusus

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan sesuai standar kompetensi dan kewenangan klinis.
- b. Memastikan kesesuaian antara kompetensi individu dengan kewenangan klinis (clinical privilege) yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Mengidentifikasi capaian indikator mutu asuhan keperawatan dan tingkat kepatuhan terhadap standar praktik profesional.
- d. Mengevaluasi kepatuhan tenaga keperawatan terhadap kode etik profesi dan peraturan internal rumah sakit.
- e. Mengidentifikasi dan menganalisis kasus pelanggaran etik dan disiplin serta memastikan tindak lanjut yang objektif, transparan, dan edukatif.
- f. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direktur Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.
- g. Menjadi dasar perencanaan program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD).



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

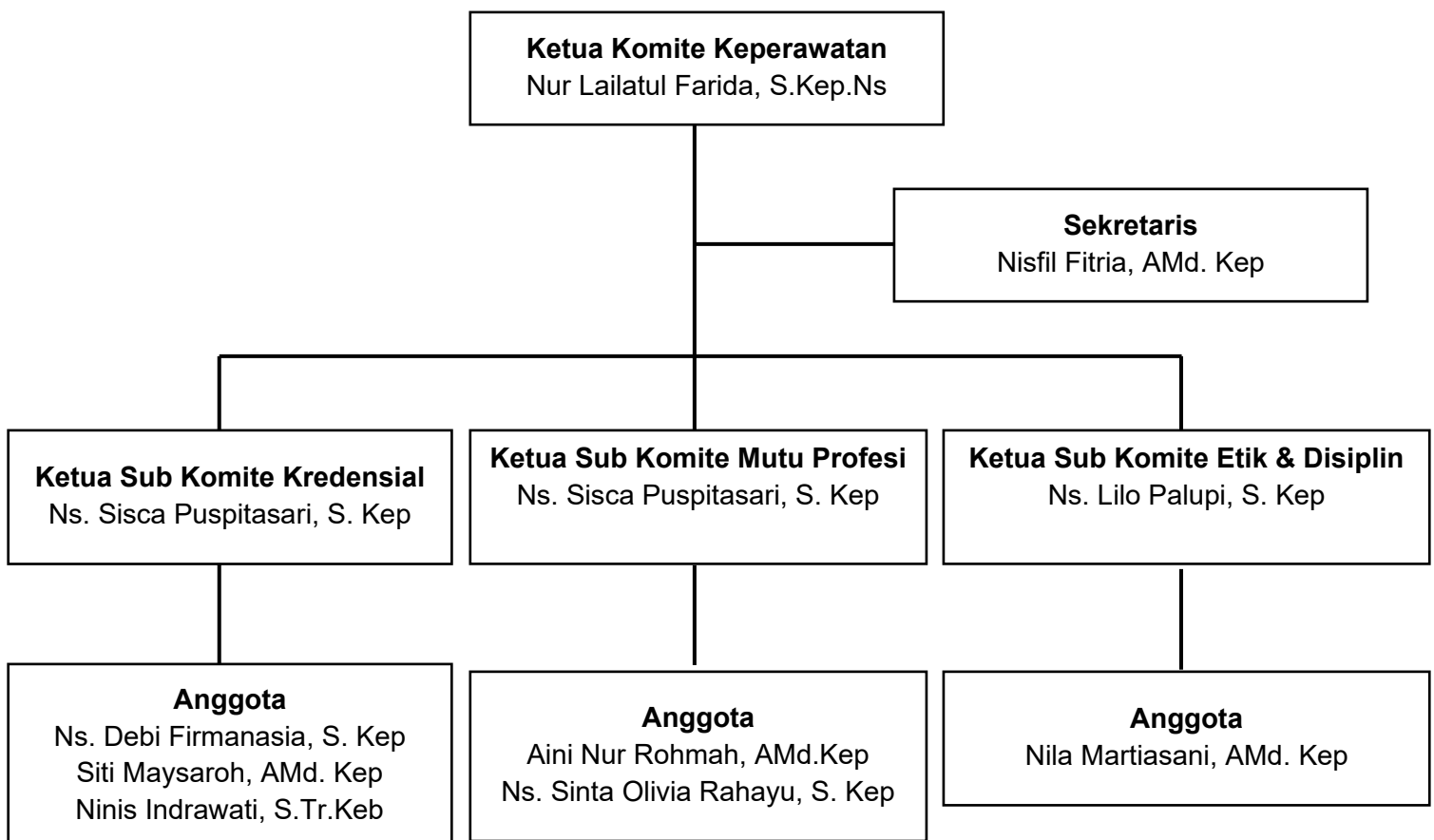
2.3 Motto

“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) Nilai Budi Utama

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



Bagan 2.5.1 SOTK Komite Keperawatan



BAB III

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Sub Komite Kredensial

3.1.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Kredensial tenaga perawat baru
2. Rekredensial tenaga keperawatan
3. Verifikasi STR dan SIP
4. Penetapan Kewenangan Klinis

3.1.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.1.2.1 Hasil Kegiatan Sub Komite Kredensial

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kredensial perawat baru	100%	100%	Dilaksanakan sesuai jadwal
2	Rekredensial tenaga perawat	100%	92%	Sebagian dokumen belum lengkap
3	Verifikasi STR/SIP	100%	100%	Seluruh dokumen aktif
4	Penetapan kewenangan klinis	100%	100%	Sudah diperbaharui

Tabel 3.1.2.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Belum seluruh perawat memahami kewenangan klinis sesuai jenjang PK	Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait kewenangan klinis di setiap unit
2	Masih terdapat perawat yang belum mengajukan kenaikan jenjang karir profesional	Melakukan pendampingan penyusunan portofolio jenjang karir

Tabel 3.1.2.3 Jumlah Tenaga Keperawatan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis PK				Total
		Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3	
Perawat						
1	D3 Keperawatan	-	34	60	2	96
2	D4 Keperawatan	1	-	1	-	2
3	Ners	18	34	39	8	99
Total		19	68	100	10	197
Bidan						
1	D3 Kebidanan	-	3	5	-	8
2	D4 Kebidanan	3	1	9	-	13
3	S1 Kebidanan	-	1	1	-	2
Total		3	5	15	0	23

Tabel 3.1.2.4 Jumlah Tenaga Keperawatan Berdasarkan Jenjang Klinis Setiap Unit

No	Unit	Pendidikan	Jenis PK			
			Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3
1	Hemodialisa	D3 Keperawatan	-	-	2	-
		Ners	-	1	2	-
2	ICU	D3 Keperawatan	-	1	5	-
		Ners	-	-	6	-
3	IGD	D3 Keperawatan	-	3	5	-
		Ners	2	7	8	-
		D3 Kebidanan	-	2	1	-



		D4 Kebidanan	-	-	1	-
4	IKO	D3 Keperawatan	-	1	7	2
		Ners	-	-	1	2
5	IRJA	D3 Keperawatan	-	3	11	-
		Ners	2	3	2	1
		D3 Keperawatan Gigi	1	-	-	-
		D3 Kebidanan	-	-	1	-
		D4 Kebidanan	-	-	1	-
		S1 Kebidanan	-	-	1	-
6	IRNA 2A	D3 Keperawatan	-	9	4	-
		Ners	-	9	2	-
7	IRNA 2B	D3 Keperawatan	-	3	3	-
		Ners	6	4	8	1
8	IRNA 3A	D3 Keperawatan	-	2	6	-
		D4 Keperawatan	1	-	1	-
		Ners	-	2	36	-
9	IRNA 3B	D3 Keperawatan	-	4	7	-
		Ners	2	6	2	-
10	Maternitas	D3 Kebidanan	-	1	2	-
		D4 Kebidanan	3	1	6	-
		S1 Kebidanan	-	1	-	-
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	-	2	4	-
		Ners	-	-	3	1
12	Manajemen	D3 Keperawatan	-	-	3	-
		Ners	-	-	1	3
		D3 Kebidanan	-	-	1	-
		D4 Kebidanan	-	-	1	-
13	Perawat Klinik	D3 Keperawatan	-	5	1	-
		Ners	-	1	-	-
Total			17	71	145	10
Total Keseluruhan			243			

Tabel 3.1.2.5 Pelaksanaan Kredensial di Trimester 3 Tahun 2025

No	Bulan	Unit	Kategori PK			
			Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3
1	Juli					
	Agustus	IGD		4		
		IRJA		1		
		IRNA 2A		2		
		IRNA 3B		2		
		NICU		1		
		Klinik		2		
	September	IRJA	1			

Tabel 3.1.2.6 Rincian Peserta Kredensial

No	Bulan	Unit	Nama Staf	Kategori PK
1	September	IRJA	1. Avita Maulidia	Pra PK
2	Agustus	IGD	1. Iga Octanesya Iksahadi, AMd.Keb 2. Intania Cahya Andini, AMd.Kep 3. Tatan Lestari, S.Kep.,Ns 4. Eka Indah Restati, S.Kep.,Ns	PK 1



		IRJA	5. Yuyun Dianita, Amd.Kep	
		IRNA 2A	6. Aulia Rahmatul Amani, Amd.Kep 7. Rodeyah, Amd.Kep	
		IRNA 3A	8. Aslah Fortuna Ramadhan, Amd.Kep 9. Lianda Agnes Puspita, Amd.Kep	
		IRNA 3B	10. Arifah'tus Soleha, Amd.Kep 11. M.Ragil Zuli Walady, Amd.Kep	
		NICU	12. Yudita Anggraini, Amd.Kep	
		Klinik	13. Ari Nita Pramesti, Amd.Kep 14. Nur Aini, S.Kep.,Ns	
3	September	IKO	1. Agung Pratama, Amd.Kep 2. Kikis Setyawati, Amd.Kep	PK 2
		IRJA	3. Miati, Amd.Kep 4. Shokibatul Khilmin Nazaha, Amd.Kep 5. Siti Julaihah, S>Kep.,Ns	
		IRNA 2A	6. Siti Maysaroh, Amd.Kep	
		MOD	7. Nuri Aini Izzah, S.Kep.,Ns 8. Khotimah, S.Tr.Keb	
		Maternitas	9. Ninis Indrawati, S.Tr.Keb	

3.2 Sub Komite Mutu profesi

3.2.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Audit dokumentasi asuhan keperawatan
2. Pendampingan clinical instructor
3. Pelatihan internal keperawatan
4. Monitoring indikator mutu keperawatan

3.2.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.2.2.1 Hasil Kegiatan Sub Komite Mutu Profesi

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Audit dokumentasi asuhan keperawatan	>90%	80%	Nilai kepatuhan 88%
2	Supervisi klinis	100%	95%	Berjalan baik
3	Pelatihan internal keperawatan	6 kegiatan	6 kegiatan	Berjalan baik
4	Monitoring indikator mutu keperawatan	100%	100%	Dilaporkan rutin

Tabel 3.2.2.2 Hasil Evaluasi dan Rencana Perbaikan

No	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan
1	Pemanfaatan hasil sudit keperawatan sebagai bahan perbaikan mutu belum optimal	Membuat rencana perbaikan menggunakan metode PDSA
2	Kegiatan pengembangan professional berkelanjutan belum merata	Menyusun kalender pelatihan keperawatan tahunan
3	Indikator mutu keperawatan pada beberapa unit belum mencapai target	Melakukan evaluasi

Tabel 3.2.2.3 Diklat Keperawatan

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan	Sasaran
----	-------------	-------------------	---------



1	Bantuan Hidup Dasar	11 Juli 2025	Perawat dan Bidan
2	Kegawat Daruratan Maternal	30 Agustus 2025	Seluruh Bidan
3	Komunikasi Efektif	13 September 2025	Perawat Bidan
4	<i>Early Warning System</i> (EWS)	18 September 2025	Perawat dan Bidan

3.3 Sub Komite etik dan Disiplin Profesi

3.3.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Sosialisasi kode etik keperawatan
2. Pembinaan disiplin profesi
3. Penanganan laporan pelanggaran etik atau disiplin

3.3.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.3.2.1 Hasil Kegiatan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi kode etik	1 kegiatan	1 kegiatan	Diikuti seluruh kepala ruang
2	Pembinaan disiplin	100%	100%	Dilaksanakan berkala
3	Penanganan laporan etik	100%	100%	Tidak ada kasus berat

Tabel 3.3.2.2 Temuan dan Tindak Lanjut

No	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan
1	Masih terdapat keluhan pasien terkait komunikasi terapeutik perawat	Pelatihan komunikasi dan pelayanan prima
2	Pelaporan insiden kejadian masih rendah	Edukasi budaya keselamatan pasien dan pelaporan
3	Pelaporan dan pembahasan kasus etik masih rendah	Sosialisasi pelaporan pelanggaran etik

BAB IV MONITORING EVALUASI

4.1 Monitoring

Tabel 4.1.1 Hasil Monitoring

No	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi/ sampel	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Monitoring pelaksanaan kredensial tenaga keperawatan	10 perawat	2 perawat belum melengkapi dokumen kredensial	Keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung	Penjadwalan ulang verifikasi dokumen dan pendampingan pengurusan berkas	Sub Komite Kredensial	Ditargetkan selesai bulan berikutnya
	Audit kepatuhan identifikasi pasien	100 observasi	Kepatuhan 95%, ditemukan 5 kasus identifikasi belum lengkap sebelum tindakan	Kurangnya ketelitian petugas	Refreshment patient safety dan supervisi langsung	Sub Komite Mutu Profesi	Masih memenuhi indikator mutu
	Monitoring penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	20 observasi	Kepatuhan handover menggunakan SBAR mencapai 88%	Sebagian perawat belum terbiasa menggunakan format SBAR lengkap	Pendampingan dan evaluasi handover oleh kepala ruang	Sub Komite Mutu Profesi	Tren meningkat dibanding trimester II
	Monitoring kepatuhan penggunaan APD	20 observasi	Kepatuhan mencapai 92%, ditemukan ketidaksesuaian penggunaan APD pada 7 observasi	Kurangnya kesadaran dan pengawasan di unit tertentu	Supervisi berkala dan penguatan budaya keselamatan kerja	Komite Keperawatan dan IPCN	Terjadi peningkatan dibanding trimester II

4.2 Evaluasi

1. Pelaksanaan program Komite Keperawatan telah mencapai sekitar 85–90% dari target yang ditetapkan.
2. Temuan terbesar masih terkait kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan handover SBAR, dan pelaksanaan kredensial.
3. Kepatuhan terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) menunjukkan tren peningkatan dibanding trimester sebelumnya.

4. Kegiatan pengembangan profesi masih perlu ditingkatkan agar seluruh perawat memenuhi target pelatihan tahunan.
5. Seluruh temuan telah ditindaklanjuti melalui supervisi, sosialisasi, audit berkala, dan pembinaan oleh masing-masing sub komite

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja Komite Keperawatan pada Triwulan III, secara umum seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, dan Subkomite Etik dan Disiplin Profesi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan, profesionalisme tenaga keperawatan, serta keselamatan pasien di rumah sakit.

Subkomite Kredensial telah melaksanakan proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan secara berkala sehingga kewenangan klinis tenaga keperawatan tetap sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun demikian, masih ditemukan keterlambatan dalam pemenuhan dokumen pendukung rekredensial dan pembaruan sertifikat kompetensi.

Subkomite Mutu Profesi telah melaksanakan audit dokumentasi asuhan keperawatan, supervisi praktik profesional, pelatihan internal, serta telaah kasus keperawatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan keperawatan, meskipun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pengisian dokumentasi keperawatan dan variasi penerapan standar praktik antar unit pelayanan.

Subkomite Etik dan Disiplin Profesi telah melaksanakan pembinaan, monitoring disiplin, serta sosialisasi kode etik profesi keperawatan. Secara umum tingkat kepatuhan tenaga keperawatan terhadap ketentuan etik dan disiplin kerja menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih ditemukan beberapa kasus terkait kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar komunikasi efektif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program kerja Komite Keperawatan Triwulan III telah berjalan efektif dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi, regulasi yang berlaku, serta prinsip keselamatan pasien.

5.2 Rekomendasi

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap masa berlaku kewenangan klinis, STR, SIP, dan sertifikat kompetensi tenaga keperawatan untuk menjamin keberlanjutan proses kredensial dan rekredensial.
2. Melaksanakan pendampingan dan supervisi secara berkelanjutan terkait dokumentasi asuhan keperawatan guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan kelengkapan rekam medis.
3. Mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Continuing Professional Development) untuk meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Memperkuat peran kepala ruangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring kepatuhan terhadap standar praktik keperawatan, kode etik profesi, dan disiplin kerja.
5. Meningkatkan frekuensi audit keperawatan dan telaah kasus sebagai sarana pembelajaran serta upaya perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
6. Mengoptimalkan implementasi budaya keselamatan pasien melalui peningkatan kepatuhan komunikasi efektif, identifikasi pasien, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan penerapan sasaran keselamatan pasien.
7. Menyusun rencana tindak lanjut yang terukur terhadap setiap temuan hasil monitoring dan evaluasi serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas perbaikan yang telah dilaksanakan.



-
8. Meningkatkan koordinasi antara Komite Keperawatan, Bidang Keperawatan, Kepala Ruangan, dan unit terkait dalam mendukung pencapaian indikator mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien..

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

Pasuruan, 30 September 2025
Ketua Komite Keperawatan

Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep